MÓDULO 7 · INVESTIGACIÓN CLÍNICA, RWE Y GENERACIÓN DE EVIDENCIA

# Fases de la investigación clínica

El desarrollo clínico de un fármaco no termina con la aprobación regulatoria: es un continuo que se extiende desde los primeros estudios en humanos hasta años después del lanzamiento comercial, y un MSL necesita entender ese continuo completo, no solo la fotografía de los ensayos pivotales que sustentaron la ficha técnica. Revisitar las fases desde la perspectiva de la generación de evidencia —más que desde la perspectiva regulatoria pura— es lo que permite a un MSL situar cualquier estudio nuevo dentro del ciclo de vida completo del producto.

- El desarrollo clínico es un continuo que no termina con la aprobación regulatoria
- Va desde los primeros estudios en humanos hasta años después del lanzamiento
- Permite situar cualquier estudio nuevo dentro del ciclo de vida completo

La Fase I y la Fase II generan la evidencia inicial de seguridad, tolerabilidad y eficacia preliminar; son estudios pequeños, muy controlados, y su función primaria es reducir el riesgo antes de invertir en estudios más grandes. La Fase III genera la evidencia confirmatoria que sustenta la aprobación: son los estudios pivotales, con la potencia estadística necesaria para las variables primarias, y habitualmente los más citados en la comunicación médica inicial de un producto. Pero es la Fase IIIb —estudios que se inician tras completar los pivotales pero antes o alrededor del lanzamiento, a menudo para explorar poblaciones adicionales, comparadores no incluidos en los pivotales, o variables secundarias de interés— y la Fase IV —estudios poscomercialización— las que generan buena parte de la evidencia con la que trabaja un MSL en su día a día, precisamente porque responden a las preguntas que emergen una vez el producto se usa en la práctica real.

**LAS FASES Y SU FUNCIÓN EN LA EVIDENCIA**

1. **Fase I-II**
   Evidencia inicial de seguridad y eficacia preliminar; reduce el riesgo
2. **Fase III**
   Evidencia confirmatoria pivotal que sustenta la aprobación
3. **Fase IIIb**
   Explora poblaciones y comparadores no incluidos en los pivotales
4. **Fase IV**
   Evidencia poscomercialización, la más usada en el día a día del MSL

Este continuo no es lineal ni se detiene: la evidencia generada en Fase IV alimenta nuevas preguntas de investigación, que a su vez pueden dar lugar a nuevos estudios observacionales, análisis de subgrupos, estudios de extensión a largo plazo, o incluso ensayos clínicos adicionales para nuevas indicaciones. Entender este ciclo permite al MSL anticipar qué tipo de evidencia es razonable esperar en cada momento de la vida

de un producto, y explicar con honestidad a un HCP por qué determinadas preguntas —por ejemplo, sobre subgrupos poco representados en los pivotales— todavía no tienen respuesta consolidada.

- La evidencia de Fase IV alimenta nuevas preguntas de investigación
- Da lugar a estudios observacionales, análisis de subgrupos o nuevos ensayos
- Permite anticipar qué evidencia esperar en cada momento y explicar los gaps con honestidad

Además de las fases clásicas, el MSL debe familiarizarse con diseños híbridos cada vez más frecuentes: los ensayos clínicos pragmáticos, que se ejecutan en condiciones más cercanas a la práctica real (criterios de inclusión más amplios, seguimiento en centros no especializados) mientras mantienen la aleatorización; y los ensayos adaptativos, que permiten modificar aspectos del diseño (dosis, tamaño muestral, criterios de inclusión) en función de los resultados intermedios, acelerando el desarrollo sin comprometer el rigor metodológico.

**DISEÑOS HÍBRIDOS**

- Ensayos pragmáticos: condiciones más cercanas a la práctica real, manteniendo la aleatorización
- Ensayos adaptativos: modifican dosis, muestra o criterios según resultados intermedios
- Aceleran el desarrollo sin comprometer el rigor metodológico

Para el MSL, dominar este mapa completo del desarrollo clínico —y no solo los estudios pivotales— es lo que le permite ser percibido como un verdadero experto en el producto y en su área terapéutica, capaz de contextualizar cualquier publicación nueva dentro de la trayectoria completa de generación de evidencia, y no solo repetir los datos del último estudio publicado.

- Dominar el mapa completo del desarrollo clínico, no solo los pivotales
- Permite ser percibido como un verdadero experto en el producto y su área
- Contextualiza cualquier publicación nueva dentro de la trayectoria completa de evidencia